

Fármacos Antidiabéticos e Controle de Peso

 O que você precisa SABER antes da aula:

1. Tipos de Insulina

(Ver tabela completa abaixo)

Principais tipos:

- Ultra-rápida (análogos): início 10-15 min, pico 1-2h
- Rápida (regular): início 30 min, pico 2-4h
- Intermediária (NPH): início 1-2h, pico 4-8h
- Lenta (glargina, detemir): início 1-2h, sem pico
- Ultra-lenta (degludec): início 30-90 min, sem pico

2. Fármacos Orais para Diabetes Tipo 2

(Ver tabela completa abaixo)

Classes principais:

- Biguanidas (Metformina)
- Sulfonilureias (Glibenclamida)
- Incretinomiméticos (Saxagliptina)
- Inibidores SGLT2 (Canagliflozina)
- Agonistas GLP-1 (Liraglutida)
- Tiazolidinedionas (Pioglitazona)

3. Controle de Peso - Conexão Importante

- **Diabetes + Obesidade:** Síndrome metabólica
 - **Fármacos que AUXILIAM perda de peso:** Metformina, agonistas GLP-1
 - **Fármacos que PODEM causar ganho:** Sulfonilureias, insulina (dose alta)
-

Pontos de Atenção (Katzung p. 779-783)

1. **Lipodistrofia:** Alternar locais de aplicação da insulina
 2. **Hipoglicemia:** Principal efeito adverso da insulina
 3. **Resistência insulínica:** Fator limitante no tratamento
 4. **Algoritmo de tratamento:** Metformina = 1ª linha no T2DM
-

 **TABELA 1: Tipos de Insulina**

Tipo	Início de ação	Pico	Duração	Uso típico	Ano
Ultra-rápida (análogos)	10-15 min	1-2h	3-5h	Bolus pré-refeição	1990/2000
Rápida (regular)	30 min	2-4h	5-8h	Bolus, infusões	1920
Intermediária (NPH)	1-2h	4-8h	12-18h	Basal	1940
Lenta (glargine, detemir)	1-2h	Sem pico	20-24h	Basal 1x/dia	1951/52
Ultra-lenta (degludec)	30-90 min	Sem pico	>42h	Basal flexível	1951/52

 **Dica:** Ultra-rápidas e ultra-lentas são mais modernas e proporcionam melhor controle glicêmico com menos hipoglicemias.

 **TABELA 2: Fármacos Orais para Diabetes Tipo 2**

Classe	Mecanismo de Ação	Exemplos
Biguanidas	↓ gliconeogênese hepática	Metformina
Sulfonilureias	↑ secreção insulina pancreática	Glibenclamida, Glimepirida
Incretinomiméticos	↑ GLP-1, ↓ glicemia pós-prandial	Saxagliptina, Sitagliptina
Inibidores SGLT2	↓ reabsorção renal glicose	Canagliflozina, Dapagliflozina
Agonistas GLP-1	↑ secreção insulina, ↓ apetite	Liraglutida, Semaglutida
Tiazolidinedionas	↑ sensibilidade insulínica periférica	Pioglitazona

 Destaque:

- **Metformina:** Primeira linha de tratamento (T2DM)
- **Agonistas GLP-1:** Ajudam no controle de peso
- **Inibidores SGLT2:** Benefício cardiovascular e renal

Anotação:

Glargina melhor insulina para controlar DM1: ultra-lenta que não faz pico

Ultra-rápida: melhor conveniência para os pacientes, pode ser aplicada antes da refeição (na frente do prato), é para cobrir o pós-prandial

Intermediária (NPH), Ultra-lenta e Ultra-lenta sem pico: insulinas para jejum

Metformina: padrão ouro para DM2: inibe produção de glicose hepática → diminui TG